

Historial Clinico - P004

Psiquiatria - Unidad de Patologia Dual - Dra. Isabel Romero Castillo - La Zubia (Granada)

1. Datos del paciente

ID Paciente	P004
NHC	NHC-2023-016478
Nombre completo	Alejandro Vega Romero
Sexo	Hombre
Fecha nacimiento	02/09/1991
Edad	34 anos
DNI	77.432.615-F
Telefono	611 567 842
Municipio	La Zubia (Granada)
Medico responsable	Dra. Isabel Romero Castillo
Especialidad	Psiquiatria - Unidad de Patologia Dual

2. Antecedentes personales

- Trastorno por deficit de atencion con hiperactividad, presentacion combinada (diagnostico tardio 2023, CIE-10: F90.2)
- Trastorno por consumo de alcohol, gravedad moderada, en remision temprana desde hace 6 meses (CIE-10: F10.20)
- Trastorno por consumo de cannabis, en remision sostenida desde 2022 (CIE-10: F12.20)
- Trastorno por consumo de cocaína, en remision sostenida desde 2022 (CIE-10: F14.20)
- Episodio depresivo moderado reactivo (2021, resuelto)
- Fractura de radio distal derecho por accidente de trafico en 2019
- No alergias medicamentosas conocidas

Antecedentes familiares: Padre: trastorno por consumo de alcohol grave, en abstinencia desde hace 8 anos. Madre: probable TDAH no diagnosticado (dificultades organizativas cronicas, impulsividad, multiples empleos). Hermana menor: TDAH diagnosticado en la infancia, actualmente sin tratamiento.

3. Historia clinica actual

Paciente de 34 anos con diagnostico de TDAH presentacion combinada realizado en 2023 a los 33 anos, tras anos de dificultades academicas, laborales e interpersonales no explicadas. Desde la infancia presenta dificultad para mantener la atencion sostenida, inquietud motora persistente, impulsividad en la toma de decisiones e incapacidad para organizarse y cumplir plazos. Repitio 3.o de ESO y 1.o de Bachillerato. Inicio tres carreras universitarias sin completar ninguna (Derecho, ADE y Magisterio). Ha tenido 9 empleos en los ultimos 12 anos, ninguno mantenido mas de 14 meses, generalmente por conflictos con superiores derivados de la impulsividad, incumplimiento de horarios o bajo rendimiento por inatention. El consumo de sustancias comenzo a los 16 anos con cannabis de uso recreativo, escalando a consumo diario entre 2014 y 2022. El consumo de cocaína fue esporadico entre 2016 y 2022, asociado a contextos de ocio nocturno (1-2 g/fin de semana). El consumo de alcohol escalo de social a diario de riesgo (70-90 g/dia) entre 2020 y 2025, en parte como mecanismo de automedicacion para la ansiedad y la inquietud interna. El paciente describe que 'el alcohol era lo unico que me paraba la cabeza'. Ingreso voluntario en unidad de desintoxicacion del Hospital de San Cecilio en octubre 2025 durante 16 dias. Desde el alta mantiene abstinencia verificada con controles toxicologicos. El diagnostico de TDAH se realizo mediante evaluacion neuropsicologica completa (WAIS-IV: CI total 112, rango normal-alto; CPT-3: deficit significativo en atencion sostenida y vigilancia; CAARS: puntuaciones clinicas en inatention, hiperactividad e impulsividad). Actualmente trabaja como tecnico de sonido freelance con horarios irregulares. Convive con su pareja desde hace 2 anos.

4. Exploracion

Aspecto general	Consciente, orientado. Aspecto adecuado. Actitud colaboradora aunque marcadamente inquieta
Psicomotricidad	Inquietud motora evidente: se balancea en la silla, tamborilea con los dedos, cruza y descruza las piernas repetidamente
Estado de animo	Eutimico. Afecto reactivo, labil ante frustracion. Se irrita brevemente al hablar de dificultades laborales
Pensamiento	Curso acelerado con tangencialidad frecuente. Salta de un tema a otro. Se pierde en detalles irrelevantes. Contenido sin alteraciones psicoticas
Atencion	Atencion sostenida claramente deficitaria. Se distrae con ruidos del pasillo y mira el movil dos veces durante la entrevista
Impulsividad	Interrompe frecuentemente. Responde antes de que se termine la pregunta. Reconoce 'actuo sin pensar y luego me arrepiento'
Cognicion	Funciones ejecutivas enlentecidas. Dificultad marcada con planificacion secuencial y gestion del tiempo. Memoria de trabajo limitada
Consumo de sustancias	Abstinencia de alcohol y otras sustancias verificada (ultimo control toxicologico negativo hace 10 dias). Consume 3 cafes al dia
Peso / Talla / IMC	76 kg - 180 cm - 23,5 kg/m2
Tension arterial	128/78 mmHg
Frecuencia cardiaca	92 lpm, ritmica

5. Tratamiento actual

Farmaco	Posologia
Metilfenidato OROS 54 mg	1 comp. en desayuno (liberacion prolongada)
Naltrexona 50 mg	1 comp. en desayuno (prevencion de recaida alcoholica)
Melatonina 2 mg	1 comp. 30 min antes de acostarse (regulacion del ritmo circadiano)

6. Resultados de laboratorio

Parametro	Resultado	Ref.	Estado	Previo
GGT	52 U/L	< 40	Alto	134 U/L
GOT (AST)	34 U/L	< 40	Normal	72 U/L
GPT (ALT)	40 U/L	< 41	Normal	78 U/L
VCM	95,8 fL	80-100	Normal	103,1 fL
CDT	1,5 %	< 1,7 %	Normal	4,2 %
Hemograma	Normal	-	Normal	Macroцитosis
Glucosa	94 mg/dL	70-110	Normal	102 mg/dL
Perfil tiroideo	Normal	-	Normal	Normal
ECG	Taquicardia sinusal leve	-	Leve	Normal

7. Plan de actuacion

1. Mantener metilfenidato OROS 54 mg. Valorar aumento a 72 mg si persisten sintomas atencionales significativos en revision
2. Monitorizar tension arterial y frecuencia cardiaca mensual (estimulante + taquicardia basal)
3. Mantener naltrexona 50 mg hasta completar 12 meses de abstinencia verificada
4. Controles toxicologicos quincenales (alcohol, cannabis, cocaína)
5. Psicoterapia individual semanal: TCC adaptada a TDAH + prevencion de recaidas en consumo de sustancias
6. Grupo terapeutico de patologia dual quincenal en el centro de día
7. Higiene del sueno: mantener melatonina, limitar cafe a antes de las 14h, pantallas apagadas 1h antes de dormir
8. Control analitico en 2 meses: perfil hepatico, hemograma, CDT
9. Coordinacion con su pareja como apoyo en estrategias de organizacion (agenda compartida, alarmas)
10. Revision en consulta en 6 semanas

AVISO: Todos los datos de este documento son completamente ficticios. Generado para el TFG: Sistema RAG de apoyo en salud mental.